EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90404
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-11 11:29:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOSE GERMAN CONTRERAS OLATE			RUN	: 7.679.840-0
F.Nac	: 28-06-1957	Edad	: 67 AÑOS, 1 MES	Género	: Masculino
Dirección	: LAS ARBOLEDAS			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-05	Fecha Egreso	: 2024-08-11 11:29:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I26-EMBOLIA PULMONAR.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

TEP segmentario basal derecho
INfarto pulmonar
Hernia de morgagni lateralizada a derecha

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I26-EMBOLIA PULMONAR. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta en SU HSC el 05/08 por cuadro de 3 dias de algia toracica y disnea progresiva. Se solicita angioTAC de torax donde se describe signos de tromboembolismo pulmonar en ramas arteriales segmentarias basales del lobulo inferior derecho, opacidad en vidrio esmerilado en el lobulo inferior derecho que podria estar en contexto de infarto pulmonar.
TAC abdomen y pelvis reporta hernia de morgagni no complicada, PESI score calculado 77 pts Wells 0 pts
Examenes de lab 04/08 -> glicemia 108; crea 0,7; amilasa 79, lipasa 64; CK 204; PCR 50; uremia 34, Na/K/Cl 138/4.1/104; Gb 12,3; Hb/Hcto 15.7/46.1; plaq 224000; segment 74%; INR 1,23; dimero D 1245.5; tropo 5,8; GSA pH 7,47, pO2 75,6; pCO2 29,4.
Se decide ingreso para estudio y manejo. Sumado a inicio de anticoagulacion a dosis plena
Durante estancia con desarrollo de peak febril, sin requeirmiento de O2 suplemenatiro, se procede a inicio de terapia ATB de amplio espectro.
EDA reporta esofagitis erosiva peptica grado C de Los Angeles, reflujo gastroesofagico, gastropatia antrocorporal,
Evaluado por cirugia, quien solicita agendar policlinico al alta para resolucion Qx de hernia.
Durante estadia con descenso posterior de aprametros inflamatorios, se procede a inicio de dagigatran, con buena respuesta.

PAciente HDN esatable, afebril, sin requerimiento de O2 suplementario, con buena tolerancia a alimentacioN VO, sin episodios de nauseas y/o vomitos,
Examenes de lab 10/08 -> orina normal, glicemia 109; crea 1,2; PCR 48,4; uremia 55; Gb 6,7; Hb/Hcto 15/44.9; plaq 319000; segment 59%; VHS 68; INR 1,16; proca 0,07;
Ex fisico Vigil; CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Paciente actualmente en su dia N° 6 de ceftriaxona, dia N° 6 hospitalizado, en condiciones de cultimar terapia ATB via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Con parametros inflamatorios en descenso, se cultimaran 7 dias de terapia ATB total, sumado a

control con parametros inflamatorios en 24 hrs
4) QUirurgico: Agendar hora con policlinico cirugia para planificacion de pabellon

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo realtivo
2. Regimen liviano a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr EV por un dia mas (completar 7 dias total)
4. Omeprazol 20 mg al dia VO por 5 dias
5. Dagibatran 150 mg c/12 hrs VO por 30 dias
6. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/!2 hrs VO por 5 dias
7. Bromuro de ipatropio 2 puff c/6hrs por AC por 7 dias
8. COntrol poli cirugia apra planificacion de pabellon
9. Control poli TACO dentro de 10 dias
10. Examenes de control 12/08

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO